

04 - 04- Troubles des Conduites Sexuelles - Pr. ADALI

(0:00 - 25:15)

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour traiter ce cours sur les troubles des conduites sexuelles. Les objectifs du cours sont reconnaître le rôle du médecin généraliste dans l'abord de la sexualité des patients en consultation reconnaître les difficultés d'aborder la sexualité par le médecin et pour le patient savoir pratiquer une anamnèse sexologique définir et citer les dysfonctions sexuelles définir les principales paraphilies reconnaître le retentissement de ces troubles sur l'individu et sur le couple et reconnaître les principes généraux de prise en charge des troubles sexuels La sexualité est une composante importante du bien-être global de l'individu Contrairement à ce que l'on peut penser, la santé sexuelle est une composante de la santé Les troubles sexuels ont la particularité d'être rarement abordés spontanément par les patients ou patientes, encore moins et encore moins par le médecin Les troubles sexuels altèrent la qualité de vie et les relations dans le couple Les praticiens ne sont pas tous formés Cependant, certains problèmes peuvent s'améliorer rien qu'avec des conseils simples et par de l'éducation sexuelle On va passer maintenant à un historique bref sur la sexualité à travers les temps Dans l'Antiquité romaine, la principale référence était la virilité La société condamnait le fait d'être passif dans la relation sexuelle La passivité était un crime chez un homme de naissance libre Il existait également des activités sexuelles qui étaient contre nature, comme la bestialité ou la nécrophilie Au XVIIIe siècle, on considérait que les personnes de couleur noire ne sont pas des êtres humains mais des super singes Toute relation entre noir et blanc était considérée comme une relation contre nature Au XIXe siècle, le modèle de référence était l'instinct sexuel Toute activité sexuelle qui ne permettait pas la reproduction était considérée comme étant une perversion Par exemple, les activités sexuelles homogénitales A la fin du XXe siècle, dans le DSM, les facteurs socio-culturels continuaient d'influencer ce qui est considéré comme normal ou pathologique en matière de sexualité Par exemple, dans le contexte de la révolution sexuelle des années 1960 et 1970, et après une rencontre entre les associations d'homosexuels et les rédacteurs du DSM L'homosexualité n'a plus été considérée comme étant une maladie Les trois phases de la relation sexuelle de Master et Johnson correspondent à La phase d'excitation, c'est la phase 1, chez l'homme elle aboutit à l'érection Et chez la femme, à la lubrification vaginale et la tumeissance du vagin La phase 2 et 3, c'est la phase en plateau, elle correspond à l'acte sexuel Les phénomènes de la phase d'excitation restent stables Elle aboutit à l'orgasme, avec à la fin l'éjaculation chez l'homme et l'orgasme clitoridien et ou vaginal chez la femme La phase 4 est la phase de résolution Caractérisé par la diminution des phénomènes de la phase d'excitation Chez la femme, plusieurs organes successifs sont possibles Mais chez l'homme, il existe une phase réfractaire pendant laquelle toute stimulation sexuelle est inefficace Il s'agit d'un graphique qui illustre les quatre phases de la relation sexuelle Maintenant, on va voir les troubles sexuels basés sur la classification des SM5 D'abord, les dysfonctions sexuelles Ce sont des troubles liés au changement dans le désir sexuel ou dans la performance sexuelle Datant au moins 6 mois, est responsable d'une détresse personnelle et ou dans le couple Chez

l'homme, il s'agit d'un trouble d'éjaculation retardée, c'est l'incapacité ou le délai marqué de l'éjaculation Trouble d'éjaculation prématurée ou précoce, c'est une éjaculation qui survient avant ou immédiatement après l'intromission Un trouble de l'érection, c'est l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante pour la pénétration Le trouble ou de diminution du désir sexuel chez l'homme, c'est l'absence ou la diminution du désir sexuel Ou bien la diminution ou l'absence de fantaisie sexuelle chez l'homme Chez la femme, les troubles de l'orgasme de la femme correspondent à l'incapacité à atteindre l'orgasme ou la diminution de l'intensité des sensations orgasmiques Les troubles de l'intérêt ou de l'excitation sexuelle chez la femme, l'intérêt pour des fantaisies sexuelles ou l'excitation sexuelle sont très réduits ou absents Les troubles liés à des douleurs génitopélviennes ou à la pénétration, appelées antérieurement vaginisme ou dysparonie C'est une douleur anticipée ou actuelle durant les activités sexuelles, particulièrement dans la phase d'intromission On passe maintenant aux troubles paraphiliques, anciennement appelés perversions sexuelles Les troubles paraphiliques ont les caractéristiques suivantes Les intérêts sexuels de la personne sont dirigés principalement vers des objets plutôt que vers des personnes Des activités sexuelles non généralement associées au coït ou un coït réalisé dans d'étranges circonstances Les troubles paraphiliques comportent des actes sexuels qui peuvent causer des torts à une autre personne, donc ça inclut une dimension judiciaire Dans les troubles paraphiliques on note le trouble exhibitionnisme, montrer ses organes génitaux, un trouble voyeurisme, observer des actes sexuels un trouble frotteurisme, se frotter sur une autre personne, un trouble pédophilie, attirance sexuelle vers les enfants et un trouble masochisme sexuel, associé de la douleur à l'activité sexuelle, exemple l'asphyxiophilie D'autres troubles paraphiliques sont notés, le trouble sadisme sexuel, associer l'activité sexuelle à infliger de la douleur au partenaire le trouble fétichisme, où l'excitation sexuelle est née d'une partie du corps ou d'un objet inanimé le trouble transvestisme, la recherche de l'excitation sexuelle dans un déguisement avec des vêtements du sexe opposé On note aussi d'autres troubles paraphiliques, notamment la mérophilie, la zoophilie, l'urophilie et autres Le trouble hypersexualité, c'est le fait de se livrer répétitivement à des fantasmes, pulsions et comportements sexuels prenant un temps excessif et qui sont à l'origine de souffrances et conséquences néfastes Le cycle clinique des troubles hypersexualité, d'abord des pensées envahissantes, obsédantes sur la sexualité Ritualisation de comportement sexuel, perte de contrôle, l'acte sexuel devient l'objectif ultime de la personne Après l'acte sexuel, un sentiment de honte et de désespoir Les formes cliniques du trouble hypersexualité, la drague compulsive et la recherche de partenaires sexuels multiples et la masturbation compulsive Les étiologies organiques des troubles sexuels peuvent être endocriniennes, comme le diabète, l'hypertiruidie, urogénital, les lésions du gland, les urétrites Les étiologies cardiovasculaires, comme les coronopathies, l'insuffisance cardiaque Les étiologies neurologiques, comme les tumeurs de la moelle, la SEP, les cancers et certains médicaments, notamment les antidépresseurs, les antihypertenseurs et les neuroleptiques Les facteurs psychologiques et les pathologies psychiatriques responsables de troubles de la sexualité L'information sur la sexualité qui est absente ou erronée L'absence de motivation sexuelle Les habiletés sexuelles réduites Les croyances dysfonctionnelles sur la sexualité qui

associent les plaisirs sexuels au mal, d'où le développement du sentiment de culpabilité et de honte. Le stress, les antécédents de violences sexuelles ou physiques, la consommation de substances psychoactives et certaines pathologies psychiatriques, notamment la dépression, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité et autres. Les facteurs événementiels ou personnels, la qualité de la relation du couple, la violence, l'incompatibilité. Un partenaire non disponible, non expérimenté ou ayant lui-même une dysfonction sexuelle. Les facteurs culturels jouent un rôle important dans les troubles sexuels, notamment l'ambiguïté des rôles sexuels, les normes sexuelles sociétales, les tabous sociaux, l'absence d'éducation sexuelle et les conflits ou la discordance entre les valeurs religieuses et culturelles. En général, la plupart des troubles sexuels ont plusieurs causes qui interagissent. Au cours du temps, les troubles s'aggravent et la réalisation du diagnostic devient complexe, car ces troubles constituent un cercle vicieux. Il s'agit d'un schéma qui illustre ce cercle vicieux des troubles sexuels, qui est cause d'une difficulté diagnostique et thérapeutique. Les dysfonctions sexuelles peuvent causer une grande souffrance psychique chez le couple, avec un sentiment de dévalorisation, une perte de l'estime de soi et de la culpabilité avec altération de la qualité de vie et des relations interpersonnelles, conflits au sein du couple et difficultés professionnelles. Des complications psychiatriques peuvent être notées aussi, notamment la dépression. Les conséquences de la paraphilie sont d'abord les conséquences judiciaires. Les sanctions légales sont toujours lourdes et le caractère récurrent des troubles expose le sujet à la récurrence, qui sera plus lourdement encore sanctionnée. Tous les paraphiles n'auront pas de problème avec la justice, par exemple, le sadique s'il rencontre son masochiste et que, à condition que ce dernier soit consentant. Le fétichiste, l'urophile, n'aura pas aussi de problème avec la justice. Pour les autres troubles, il faut penser, en plus des conséquences judiciaires, à la possibilité de l'obligation de soins, notamment chez les raptophiles, les pédophiles, les zoophiles et autres. La paraphilie peut causer une souffrance psychique car l'activité sexuelle s'accompagne de culpabilité, de honte ou de dépression. Les conséquences sociales et difficultés interpersonnelles sont notées aussi, les problèmes judiciaires, les incarcérations et surtout une difficulté à trouver un partenaire. Quelles sont les difficultés d'aborder le sujet de sexualité dont on a parlé en introduction ? D'abord pour le médecin généraliste, le manque de temps, le manque de formation sur le sujet. La gêne a évoqué un sujet encore considéré tabou dans notre société, la différence d'âge et de genre avec le patient. Médecin jeune, de sexe féminin, sujet âgé, de sexe masculin. Par exemple, la crainte des réactions des patients et la difficulté de décrypter les non-dits par le patient. Quelles sont les difficultés d'aborder le sujet pour le patient cette fois ? La gêne, la crainte d'être jugé par le médecin, l'âge et le genre du médecin là aussi. Les représentations socio-culturelles, le sujet âgé, les femmes qui ont honte d'aborder le sujet de leur sexualité. Cependant, on attire l'attention sur deux cas particuliers, notamment le sujet âgé, la sexualité du sujet âgé qui est d'actualité du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Cependant, ces patients là considèrent souvent les troubles sexuels comme d'hormones pour leur âge et n'osent pas en parler à leur médecin. Et la sexualité chez les patients souffrant de pathologies lourdes ou cancéreuses, cet aspect de la vie semble passer au second plan chez ces personnes là. Comment aborder de façon pratique la

question de la sexualité, soit en posant des questions ouvertes Par exemple, sexuellement tout va bien ? Vos relations intimes sont-elles encore comme avant ? Soit aborder sur le registre médical, vous avez beaucoup de personnes dans votre situation ou qui ont votre pathologie, par exemple le diabète, ont des troubles sexuels Et là, on peut enchaîner sur le sujet de la sexualité Il faut laisser le temps de réflexion au patient, il faut oser poser les questions, proposer une rencontre avec le partenaire, il ne faut pas prendre parti et éviter tout jugement personnel On peut aborder la sexualité comme étant une composante de la santé, il faut utiliser des termes simples et précis, compréhensibles pour le patient La communication non-verbale est aussi importante que la communication verbale, il faut savoir repérer les non-dits Expliquez au couple que les difficultés sexuelles s'amplifient avec le temps, s'ils ne sont pas pris en charge rapidement Rappelez-vous du schéma qu'on a vu sur le cercle vicieux des troubles sexuels dans les diapositifs d'avant Maintenant, quand est-ce qu'il faut aborder la sexualité du patient ? A la première consultation A la demande explicite du patient Et en cas de plainte somatique, évoquons des problèmes sexuels silencieux, notamment chez l'homme, les écoulements au peignoir, douleurs, des plaintes urinaires Chez la femme, des douleurs pélviques, des troubles menstruels et autres Quand est-ce qu'il faut aborder encore une fois la sexualité du patient ? Dans certaines périodes critiques, la période de la puberté, la période de la grossesse, la période du postpartum et lors de la ménopause Et dans les situations suivantes, en cas de maladie chronique, notamment à l'HTA, le diabète, en postchirurgie, dans le cas des maladies cancéreuses, maladies cardiaques Chez tout patient ayant un facteur de risque cardiovasculaire Et à l'occasion de l'introduction d'un traitement médicamenteux, notamment les antidépresseurs, les antipsychotiques, les antihypertenseurs et autres L'examen sexologique suit les procédures habituelles de l'examen médical D'abord, l'analyse détaillée du trouble sexuel aux différents registres somatique, psychologique, relationnel, familial, socioculturel, professionnel et religieux Explorer la vie sexuelle du patient, la réponse sexuelle et la sexualité antérieure Explorer la vie relationnelle du sujet et le rôle du partenaire Est-ce que c'est un rôle aggravant, un partenaire maladroit, inexpérimenté, égoïste, ayant lui-même une difficulté sexuelle et autres Ou bien un partenaire soutenant, qui est bienveillant, déculpabilisant, expérimenté Il faut explorer lors de l'examen sexologique les antécédents personnels somatiques et psychiatriques, les problèmes psychologiques L'examen somatique est recommandé L'orientation thérapeutique est fonction de l'étiologie et des moyens thérapeutiques Quels sont les moyens thérapeutiques dont on dispose ? La sexothérapie d'abord Elle agit surtout sur la composante anxiété de performance Comporte une part importante d'information sur la sexualité Comporte un travail sur l'amélioration de la communication dans le couple Elle comporte la prescription d'exercices sexuels à domicile et leur discussion en séance Il s'agit essentiellement de décentrer les préoccupations du sujet de la performance sexuelle en elle-même Pour la recentrer sur les sensations, la communication détendue et le plaisir sexuel Les traitements médicamenteux ou chirurgicaux L'efficacité de la clopipramine, de la paroxythine et de la sertraline a été démontré dans le traitement de l'éjaculation précoce On utilise l'effet secondaire de ces antidépresseurs qui est le retard d'éjaculation pour traiter l'éjaculation précoce Le traitement médical ou chirurgical est fonction de

l'éthiologie organique Un accompagnement sexothérapique est souhaitable dans tous les cas Je vous donne des exemples de la prise en charge spécifique de certaines dysfonctions sexuelles Notamment devant une éjaculation prématurée, avoir des rapports sexuels réguliers, se concentrer sur ses propres sensations pour limiter l'excitation Apprendre à respirer par le ventre, communiquer avec le partenaire et prescrire certains traitements médicamenteux Devant un trouble du désir chez la femme, explorer le thème hygiène et séduction Éviter les rapports sexuels forcés, stimuler l'imaginaire par des lectures, par des vidéos Proposer plus de préliminaires et de caresses Encourager la femme à dire ce qu'elle aime et à prendre l'initiative dans l'acte sexuel Devant une dysfonction érectile, si c'est une problématique simple, isolée, un couple motivé, l'information sexuelle est suffisante Les conseils d'hygiène de vie, changement de traitement en cours, notamment les antépartenseurs Prescrire des médicaments d'aide à l'érection, des médicaments qu'on prescrit de façon ponctuelle, notamment l'acide dénaphile Maintenant on va passer à la prise en charge des paraphilies C'est une prise en charge qui est un peu difficile Le but du traitement est de supprimer les comportements paraphilies nuisibles au sujet et éventuellement à autrui Et améliorer la qualité de vie du sujet et atténuer sa souffrance Les moyens thérapeutiques dont on dispose sont Les psychothérapies spécifiques d'inspiration cognitive ou comportementale Qui aident le patient à prendre conscience des conséquences de la paraphilie Ces moyens psychothérapeutiques visent aussi à apprendre au patient à éviter les occasions de mettre en œuvre son activité paraphilique Remplacer les idées et les comportements paraphiles par des idées et des comportements non-paraphiles Les traitements médicamenteux sont très peu spécifiques On peut prescrire les antidépresseurs IRS qui sont actifs probablement par leur effet secondaire anti-libido Et les traitements anti-androgènes sont très efficaces aussi par la suppression du désir Quelle est la place du médecin généraliste dans la prise en charge et dans le diagnostic des troubles sexuels ? Il faut savoir que le médecin généraliste est le médecin de premier recours Il a pour rôle le dépistage d'abord de la dysfonction sexuelle Il faut qu'il pose des questions ouvrant sur la sexualité Connaît les éléments d'une bonne anamnèse sexologique Et recherche un problème organique ou une origine iatrogène médicamenteuse Éduquer et informer le patient sur la sexualité Encourager la communication au sein du couple Renseigner des techniques simples Et traiter en fonction de ses compétences Ne jamais hésiter à demander un avis spécialisé si besoin Je conclue mon cours avec ce schéma qui est très intéressant Et qui résume un petit peu les procédures de prise en charge et d'anamnèse sexologique pour le médecin généraliste On pourrait discuter de ce schéma lors de notre séance prochaine interactive Je vous remercie pour votre attention